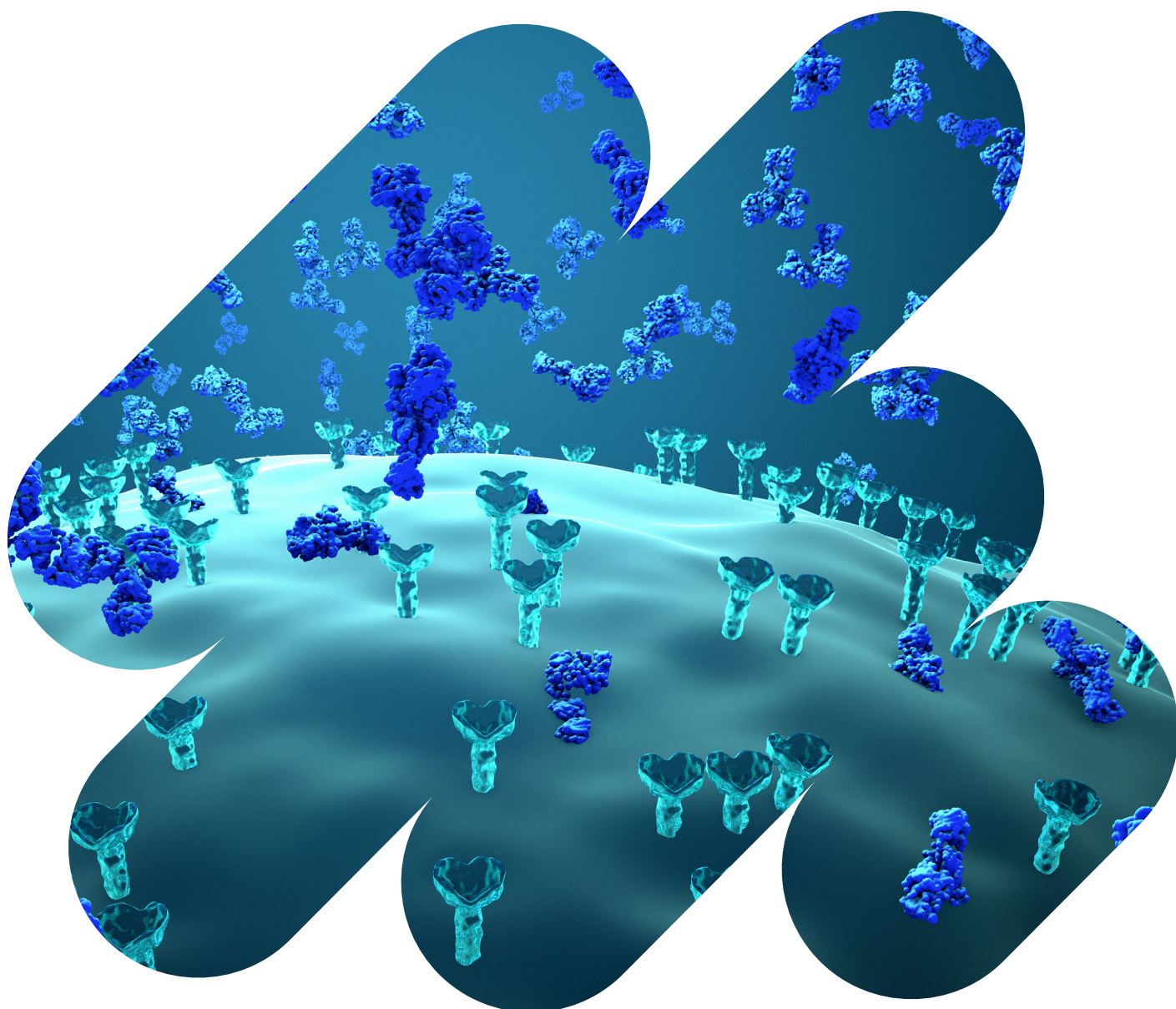


白皮书

印度聚焦：肺癌试验准备

RAINA SINGH PAPLIKAR, 亚太区研发解决方案、市场营销与企业传播首席官, IQVIA
王希利娅, 市场经理, 研发解决方案, IQVIA亚太区



目录

执行摘要	1
全球肺癌格局	2
印度的肺癌现状：差距与发展潜力	5
监管演变助力更快试验	6
运行就绪和场地基础设施	7
来自印度临床研究界的呼声	9
IQVIA优势10	
关键点	10
结论	11
免责声明	11
致谢12	
参考文献	13
关于作者	14

执行摘要

肺癌仍然是 **全球癌症死亡的首要原因** ,以近 **2022年**记录了**250万新增病例**和**180万死亡病例** 仅在中国，估计有 **8万新病例**和**7.5万死亡** ，将肺癌位列该国癌症前五。

这些进步得到了印度临床研究人员和机构的领导，包括由塔塔纪念医院领衔的国家癌症网络，该网络连接了300多所医院，并覆盖了印度约60%的癌症负担。

这些数据突显了全球的紧迫性和国家的负担，这要求更快地获得创新疗法。



的介绍 **新药和临床试验规则 (NDCTR) 2019** 它为审批时间线带来了新的可预测性。对基础设施的投资在全国范围内创建了一个由六十多个已绘制、可进行试验的肺癌试验中心组成的网络。生物标志物检测的日益普及也使精准驱动试验设计的可行性越来越高。

这些发展构建了指导本白皮书的三大主题：肺癌研究的全球紧迫性、印度通过临床试验应对日益增长负担的机遇，以及IQVIA将全球专业知识与本地执行相结合的差异优势。通过这些视角，本白皮书探讨了印度如何准备更有效地为非小细胞肺癌 (NSCLC) 和小细胞肺癌 (SCLC) 疗法的发展做出贡献，以及为什么现在是临床试验合作伙伴将印度纳入其全球试验战略的时机。



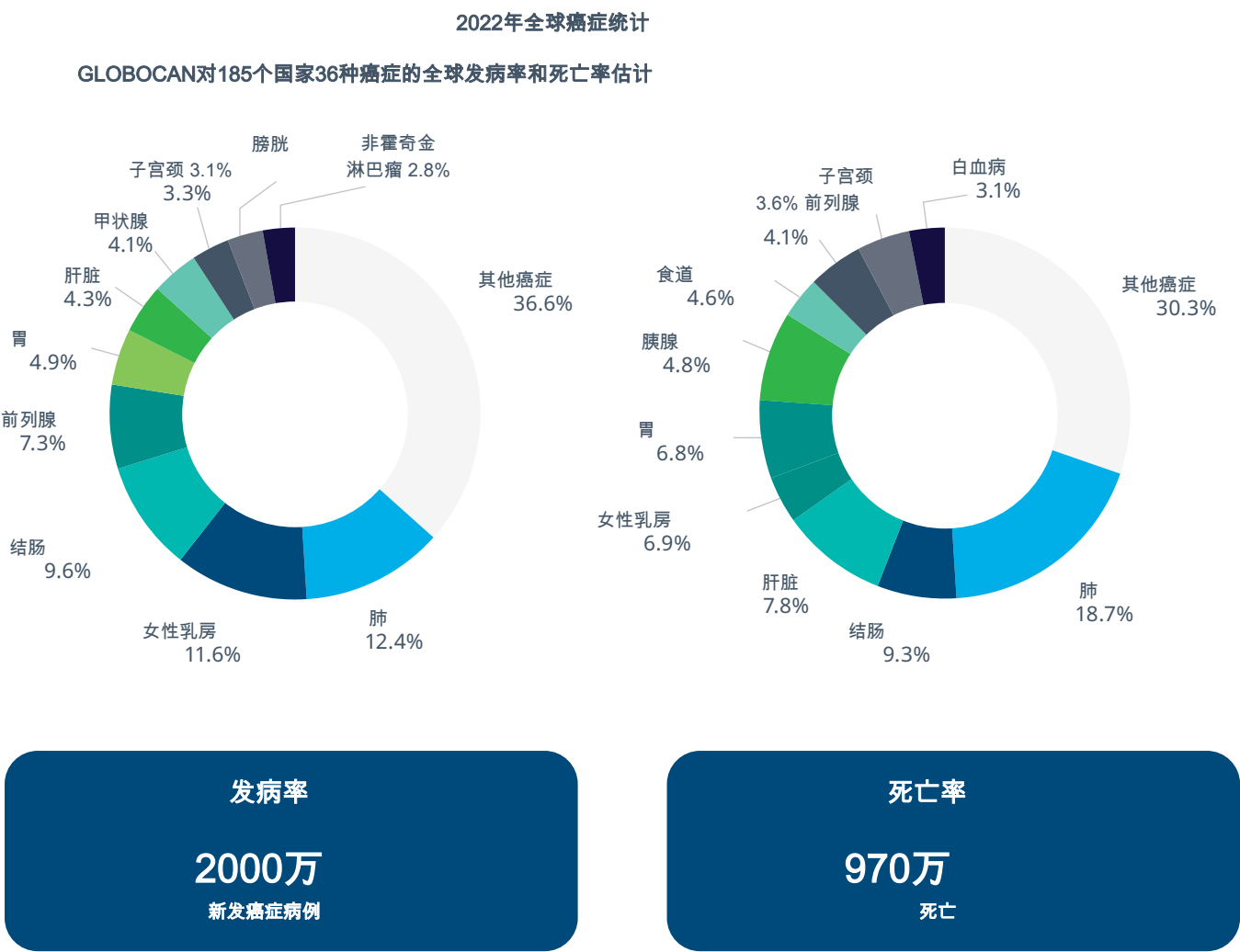
全球肺癌格局

2022年肺癌是最常被诊断的癌症，导致近250万新病例和估计180万人死亡。

在全球范围内，肺癌在规模和影响方面继续主导肿瘤学领域。它占近 2022年新增25万病例和18万人死亡，使其成为全球最常见的癌症诊断疾病以及癌症相关死亡的主要原因。

— 安东尼奥·罗西 主任医师，肿瘤/血液学卓越中心

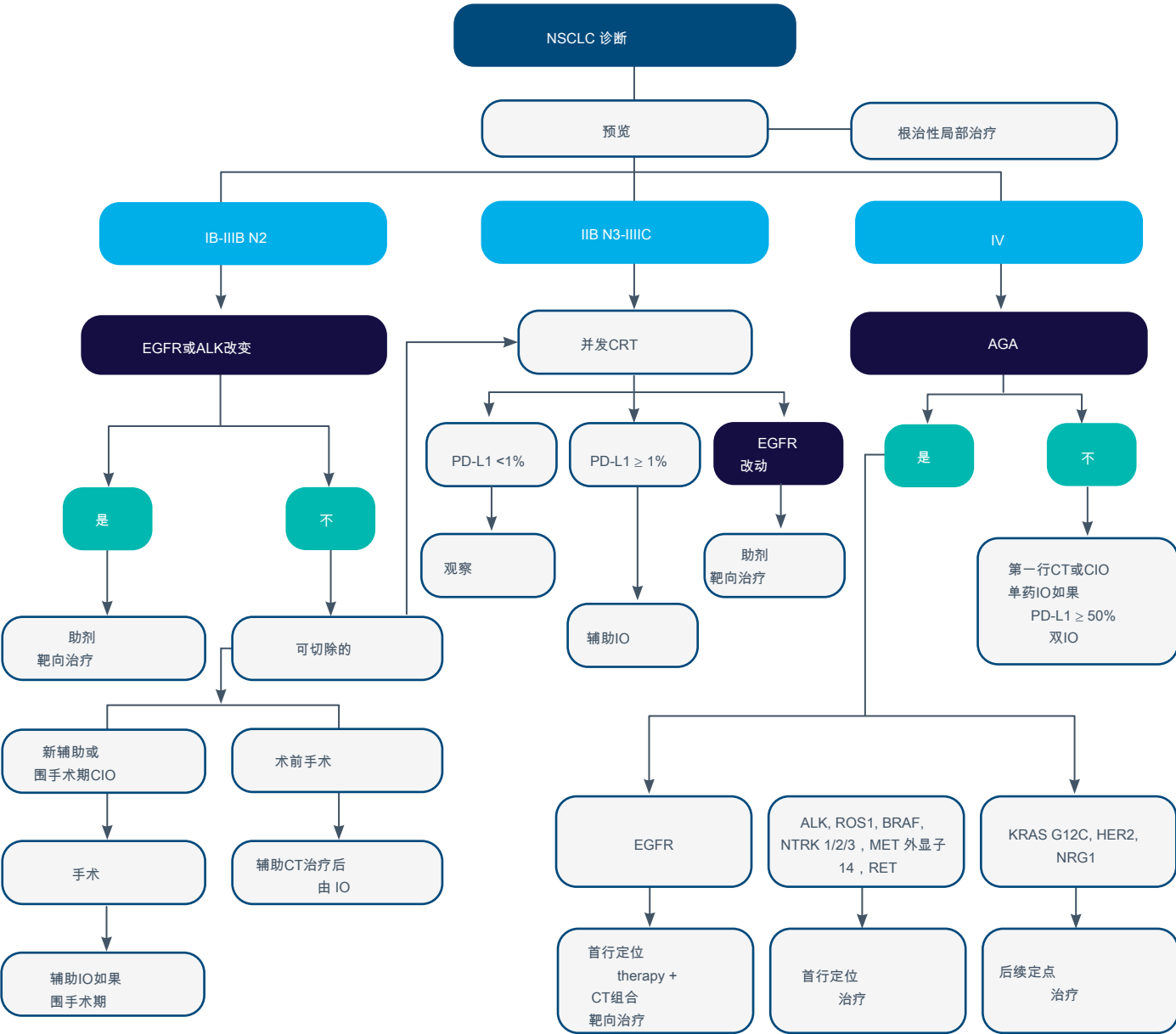
图1：全球发病率和死亡率（GLOBOCAN 2022）：肺癌 worldwide 首位，病例数 2.5 百万，死亡数 1.8 百万



来源：Bray F，等。CA Cancer J Clin 2024；74：229-263

负担主要由两类疾病塑造：非小细胞肺癌（NSCLC）和小细胞肺癌（SCLC）。非小细胞肺癌占大多数病例，近年来发生了显著转变，从依赖化疗转向靶向治疗、免疫治疗和生物标志物驱动疗法。基因组分析的进步现在使得根据肿瘤的分子特征定制治疗方案成为可能，为改善预后开辟了新的机遇。

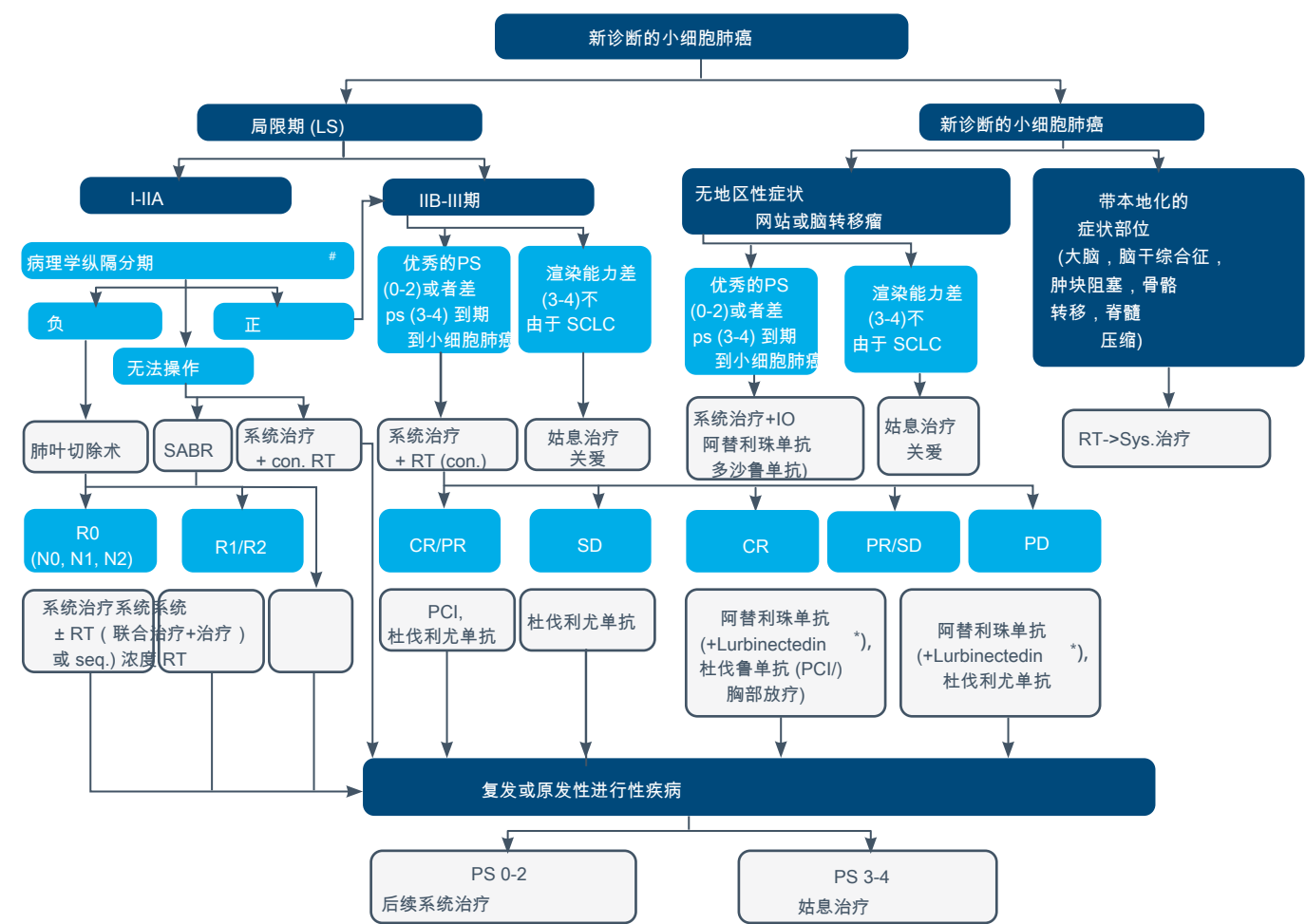
图2：2025年进行中的非小细胞肺癌试验集中在晚期疾病，免疫治疗、靶向药物和抗体药物偶联物方面活动活跃



来源：Jeon H, 等人. 肺 2025

SCLC 提出了一个更复杂的挑战。历史上进展有限，但像化疗免疫疗法联合治疗和新型T细胞 engaging 剂等新进展开始为这些患者扩展治疗可能性。

图3：全球小细胞肺癌研究已扩展至2025年的近1900项试验，并在局限期和广泛期都越来越关注免疫治疗和新型药物



纵隔分期检查包括纵隔镜检查、纵隔切开术、经支气管镜或食管超声引导活检以及胸腔镜辅助手术。如果内镜淋巴结活检结果阳性，则不需要额外的纵隔分期检查
* 美国食品药品监督管理局已授予补充新药申请 (sNDA) 优先审评，预计美国食品药品监督管理局的决策日期为2025年10月7日

缩写：CR：完全缓解；PCI：预防性颅脑照射；PD：疾病进展；PR：部分缓解；PS：体能状态；RT：放射治疗；SD：疾病稳定；SVC：上腔静脉；Con.：同期；Sys.：全身；Seq.：序贯

来源：1. NCCN指南 SCLC_ V4.2025

全球研究管线反映了这种强度。到2025年年中，在非小细胞肺癌 (NSCLC) 中已有超过1600项试验正在进行，在肺鳞状细胞癌 (SCLC) 中接近1900项，跨越多个地区。大多数集中在对晚期疾病的研究，并关注新的免疫疗法组合、靶向疗法和抗体-药物偶联物。这一轮研究展示了肺癌仍然是肿瘤学创新的领跑者。

对于医疗保健创新者而言，这些全球趋势为何拥有庞大患者群体和不断发展的研究基础设施的地区，例如印度，对肺癌试验推广的未来日益至关重要设定了背景。

印度的肺癌现状：差距与发展潜力



印度面临着巨大的癌症负担，接近 2022年新增150万例诊断，约有一百万例死亡。肺癌位居该国癌症发病率前五位，估计 那年新增80,000例病例和75,000例死亡。

尽管如此规模，与全球活动相比，印度的试验领域仍然有限。大多数癌症试验是III期研究，相对较少I期和II期计划。这种对后期研究的选择减少了印度患者早期阶段获得新疗法的机遇。虽然近年来印度专属的研究稳步增加，但跨国参与则不太稳定。

图4：肺癌是印度排名前五的癌症之一，但大多数正在进行的研究仍处于III期，限制了早期获得新疗法

正在进行的非小细胞肺癌临床试验主要针对一线晚期疾病和III期

非小细胞肺癌分期	TOTAL	第四阶段 试验	PASE III 试验	第二阶段 试验	第一阶段 试验	其他
任意阶段	27	1 (任意行)	22 (2L中1个)	2	1	1 (Molecular 分析)
任意阶段	1	0	1	0	0	0
任意阶段	2	0	2	0	0	0
任意阶段	24	0	22 (2L中1个)		1	1 (Molecular 分析)

临床试验.gov 于2025年7月28日访问

印度非小细胞肺癌的治疗格局正在不断发展，越来越重视组织学、诊断分期和生物分子特征分析。首次诊断时的综合检测，特别是在非鳞状组织学中，对于指导治疗选择至关重要。然而，下一代测序技术的广泛采用仍然不一致，由于成本限制或晚期表现，许多患者仍然没有得到指南推荐的分子检测管理。

“ndctr 2019 为审判批准带来了真正的可预测性。我们看到的绝大多数批准都在我们监管机构承诺的 90 个工作日内完成。”

— 施韦塔·普拉丹 主管，临床运营，印度，IQVIA

小细胞肺癌的进展较为缓慢。过去几年中，局限性和广泛期疾病的治疗效果有所改善，这主要得益于化疗免疫疗法的整合。尽管其生物学特性具有侵袭性且预后较差，但小细胞肺癌在印度的研究组合中仍然代表性不足，仅有少数活跃的研究。

肿瘤学领域专家委员会（SEC）会议频率已提高至每月至少两次，并正在为嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）和细胞与基因治疗（CAGT）等新疗法组建专门委员会。更新的生物类似药指南进一步使印度与全球标准保持一致。

地理差异进一步说明了这种不平衡的地形。大型城市研究机构在试验基础设施和诊断方面配置更好，而东北印度等地区继续报告高癌症负担但试验机会有限。在全国范围内扩展研究机构的地域覆盖对于确保更公平的参与至关重要。

能力建设举措也在加强生态系统。国家癌症、糖尿病、心血管疾病和中风防治计划（NPCDCS）已改善早期发现、筛查和治疗基础设施，迄今为止已升级770个区级诊所、19个国家癌症研究所和20个三级护理中心。此外，中央药品标准管理局（CDSCO）和印度医学研究会（ICMR）已发布试验手册、举办临床研究研讨会并推出数字平台。这些努力包括SUGAM印度用于监管提交和批准的在线平台（在梵语中意为“易于接近”），以及用于简化提交的在线临床试验申请管理系统（OCTAMS）。

印度肺癌现状揭示了紧迫的挑战和明确的发展潜力。更广泛的地基因检测、更多早期阶段和小细胞肺癌研究，以及对代表性不足地区的更大投资，对于使试验能力与患者需求相协调至关重要。

监管演变助力更快试验

印度开展肿瘤学研究的准备充分的关键驱动因素之一是其监管环境的转变。2019年NDCTR的引入标志着一个转折点，为临床试验批准带来了更大的可预测性和透明度。

这些改革共同缩短了审批时间线，提高了监督质量，并扩展了印度支持复杂肿瘤学试验的能力。对于医疗保健创新者而言，这一转变代表了一个明确的机会，可以在早期和晚期开发计划中纳入印度，并对监管途径有更大的信心。

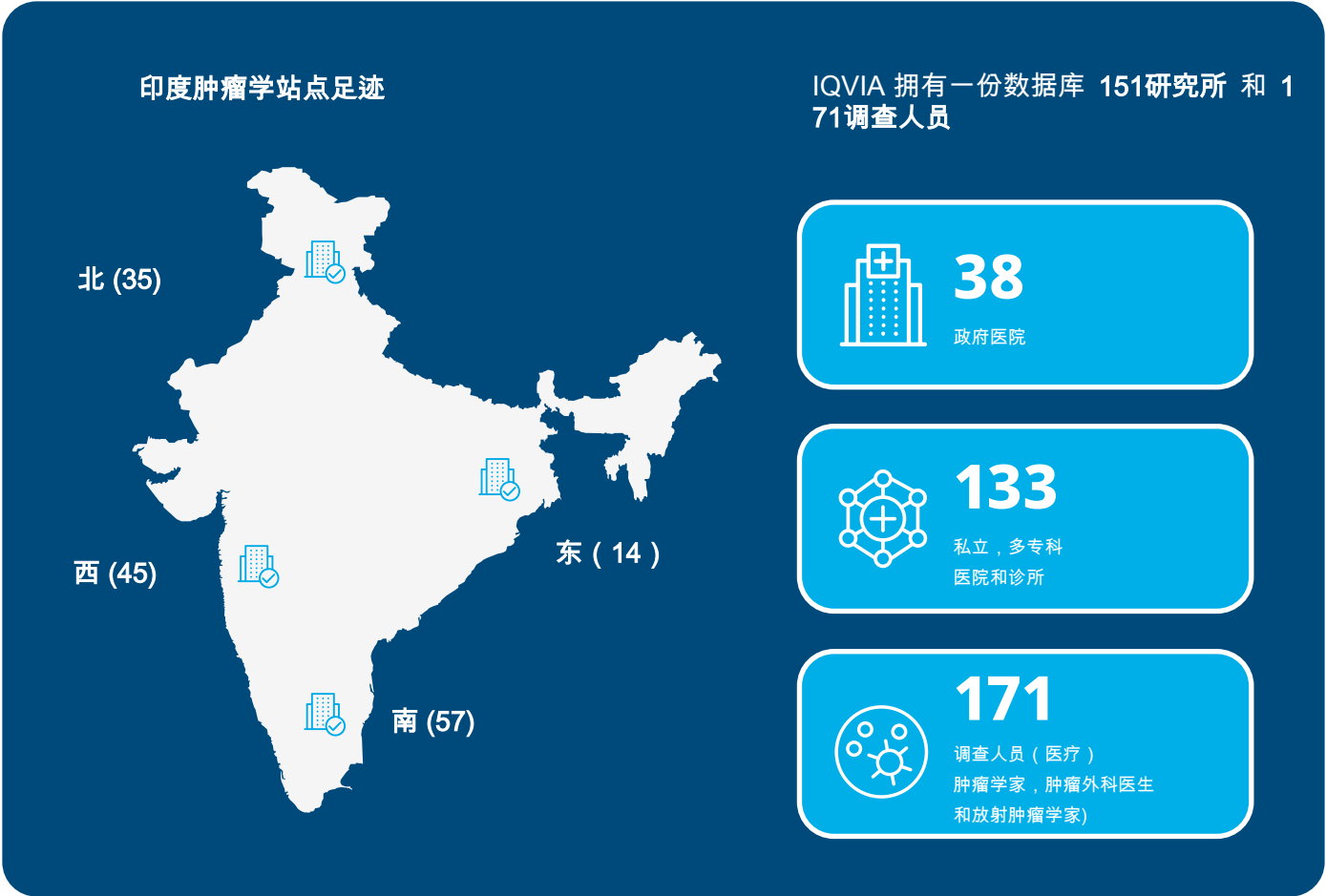
这种更强的可预测性为药物开发者创造了更友好的环境，并增加了印度作为试验目的地的信心。

运行就绪和场地基础设施

印度支持肿瘤学试验的能力不仅超越了监管改革，还包括其研究中心的实力、网络和交付模式。IQVIA 在该国活跃了数十年，早在 1997 年就是首家在印度启动全球临床试验的合同研究组织 (CRO) 使其得以与领先的医院、癌症中心和临 (RO)。这种长期的床研究人员发展密切的合作关系。

今天，IQVIA 在印度维护着一个包含超过60个已映射的肺癌试验就绪试验中心的数据库。这些中心包括政府医院、私立机构以及新加入全球试验但对临床能力强大的医院。每个中心都经过对基础设施、患者获取和伦理委员会准备情况的仔细评估，以确保临床操作人员能够识别出能够快速启动和提供高质量服务的中心。

图5：IQVIA支持的印度肿瘤试验准备机构和研究人员分布



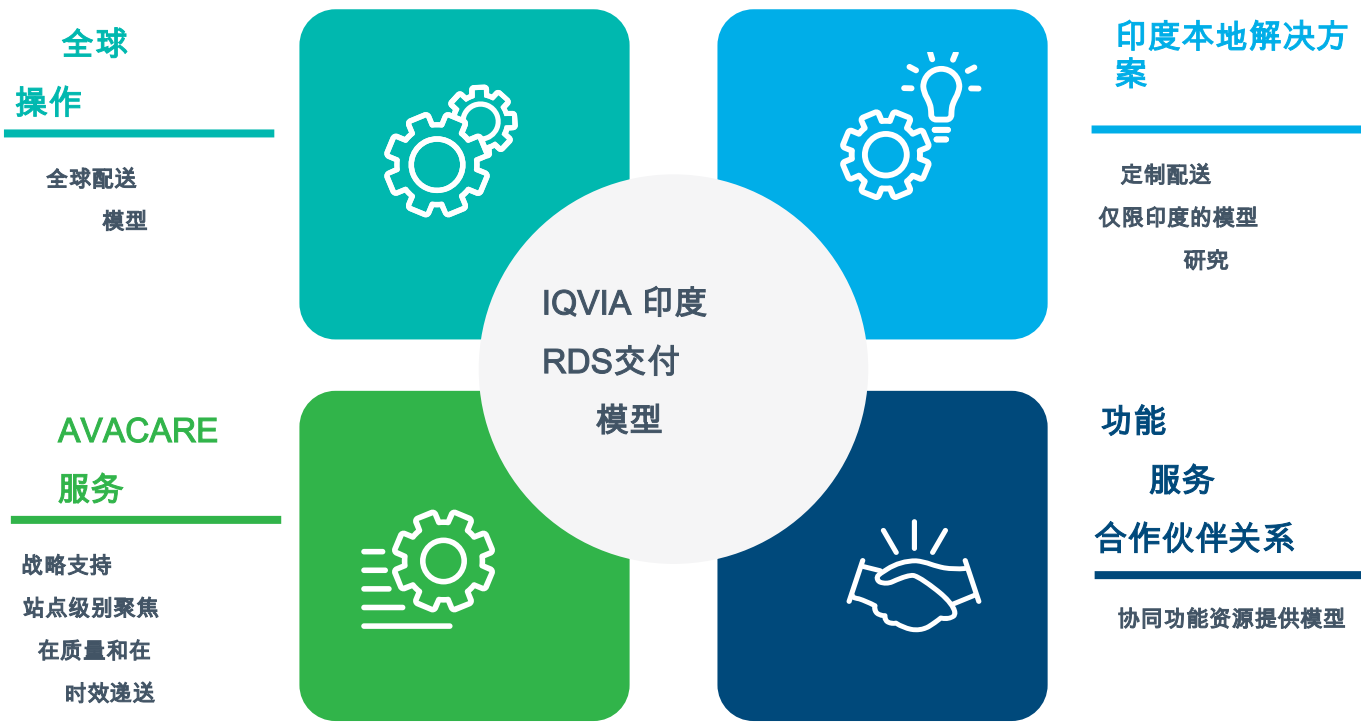
一个关键的不同点是Avacare模式，该模式在试验中心设立专门的临床研究协调员（CRC），以加强运营执行。这种支持有助于加速研究启动、改善招募时间线，并确保数据收集的一致性。该模式在肿瘤学领域尤其有效，因为试验通常很复杂，需要在临床医生、实验室和临床试验操作者之间进行高水平的协调。

这种全球标准与本地专业知识的结合既保障了数据完整性，又保持了灵活性，以满足印度试验中心的独特需求。

这些元素共同突显了印度开展大型III期研究和日益复杂的早期生物标志物驱动的肿瘤试验的运作准备情况。对于临床试验操作人员而言，映射的研究中心、嵌入式协调员和质量监督相结合，为加速该国肺癌研究创建了一个强大的平台。

印度临床试验交付的核心仍然是质量监管。IQVIA应用印度特定的质量计划，该计划由基于风险的监测方法和经过充分培训的临床研究助理（CRAs）提供支持。

图6：IQVIA印度的研发解决方案（RDS）交付模式结合全球运营、本地解决方案、职能服务合作伙伴关系以及Avacare站点支持，以确保质量和及时的临床试验交付



来自印度临床研究界的呼声

印度的肿瘤学生态系统不仅由其机构定义，还由领先的临床研究人士定义。两位杰出人士在网络研讨会期间分享了他们的观点，强调了印度提供的患者数量和研究能力。

奇拉格·德赛博士，Ahmedabad的HOC Vedanta肿瘤内科顾问，强调了其中心的试验经验和患者群体。

“在典型的一年中，我们看到大约有5,500例新发癌症病例，其中大约有700例是肺癌病例。我们与多家实验室建立了合作关系来开展我们的分子工作，凭借这一点，我们能够参与那些要求我们提供分子靶向治疗的试验。”

— 查拉格·德赛博士 顾问肿瘤内科医生，HOC Vedanta，印度艾哈迈达巴德

德赛博士阐述了印度独立的肿瘤学网络如何整合实验室合作和分子检测，以确保患者能够参与生物标志物驱动的临床试验。他的机构已开展超过120项肿瘤学研究，包括针对KRAS、EGFR和CAR-T疗法的试验。

范蒂塔·诺罗恩哈博士，孟买塔塔纪念癌症中心肿瘤科教授和医学肿瘤学家，强调了印度最大的癌症研究机构规模和国家范围：

塔塔纪念医院每年注册约60,000名各类癌症患者，包括儿童和成人。由塔塔纪念医院领导的国家癌症网络目前有全印超过300家医院参与其中。国家癌症网络覆盖了印度约60%的癌症病例。

— 瓦妮塔·诺兰哈博士 教授、肿瘤内科医生，塔塔纪念中心，印度孟买

诺罗纳博士强调了印度基础设施的深度，以及通过国家癌症网络（该网络连接全国300多家医院）进行大型、多中心研究的能力。这个网络为广泛的招募创造了机会，并确保研究结果更能代表印度多样化的种群。

这些观点共同展示了印度的临床研究界正在建立支持全球和国内肺癌试验所需的合作、基础设施和患者准入。

IQVIA优势

全球-本地合作模式： 肿瘤卓越中心的专业知识配合印度的运营团队。

我们支持医院的第一步是引进合适的研究，设计完善的方案，并支持您有效执行这些方案。

以患者为中心的临床试验交付 招募支持，临床研究助理 (C R A) 培训，患者材料，监管协助。

现在，大多数肿瘤学研究在印度都可行。我们与临床运营、可行性团队和医疗团队合作，支持试验中心招募合适的患者。

— 布赖恩·凯尔 首席医疗官，IQVIA生物技术公司及全球负责人，IQVIA血液肿瘤卓越中心

— 安茹·高帕 医疗总监，肿瘤学/血液学，医学科学与战略，亚洲

关键点

印度在全球肺癌研究格局中正迈向更强劲的地位。凭借全球最高的疾病负担之一，该国将在非小细胞肺癌和肺小细胞癌的研究中扮演更有意义的角色。

- 

印度是全球肺癌试验的新兴中心

由于拥有世界上最高的疾病负担之一，印度在非小细胞肺癌和肺小细胞癌的研究中具有重要贡献潜力。
- 

临床研究领导力很强

像塔塔纪念医院这样的中心以及像国家癌症网络这样的网络能够进行广泛的病人招募和多中心协调，覆盖了印度近60%的癌症负担。
- 

监管环境精简且可预测。

NDCTR 2019及后续改革已将审批时间缩短至90个工作日内，同时专业委员会和数字平台为肿瘤学研究提供更清晰的指导。
- 

iqvia提供经过验证的全球-本地支持。

在印度拥有数十年的运营经验、映射的肺癌研究中心以及Avacare等交付模式，IQVIA使临床合作伙伴能够实现速度、质量和以患者为中心的结果。
- 

测试基础设施正在扩张

印度有60多个已映射、适合试验的肺癌试验中心，提供政府及私立机构的准入，并由专门的场地协调员和针对印度的质量监督支持。

这些要点表明为什么印度应该是全球试验组合中不可或缺的一部分。在早期和晚期开发中都包括印度，使临床运营商能够加速研究，扩大患者获取，并产生反映全球肺癌多样性的数据。

结论

印度在肿瘤学研究中的地位正在改变。监管改革、映射的试验准备中心以及国家癌症网络等网络的覆盖范围，为更雄心勃勃且全球一致性的研究奠定了基础。印度的试验交付现在比以往任何时候都更具可预测性、更具可扩展性，并得到了更好的支持。

区别于这个环境的是能够将规模与质量相结合的能力。多样化的患者群体、经验丰富的研究人员以及得到加强的基础设施使得能够运行操作高效且科学严谨的试验。

IQVIA 在印度的长期存在，得益于其全球专业知识和本地交付模式，确保了这一潜力可以转化为可靠的成果。随着这些要素的到位，印度已准备好在肿瘤学研究中承担更大的角色，提供推进下一代疗法的所需能力和资源。

免责声明

这份白皮书基于2025年9月19日举行的“聚焦印度：肺癌试验准备情况”网络研讨会中分享的见解、监管发展、数据和专家观点。

它为全球制药和临床运营团队提供了一个清晰的视角，了解印度支持复杂癌症研究的准备情况。网络研讨会突出了监管改革、场地能力和科学专业知识如何汇聚，将印度定位为肺癌研究的一个战略枢纽。

该内容反映了活动当时发言人和贡献者的观点和经验。尽管已尽一切努力确保准确性，但建议读者查阅官方指南和监管来源以获取最新信息。该白皮书仅用于信息目的，不构成医疗、法律或监管建议。

致谢

特别感谢以下专家贡献者，他们的领导力和见解为这份白皮书提供了信息：

布赖恩医生，首席医疗官，IQVIA生物技术公司 & 全球卓越中心负责人，IQVIA血液肿瘤中心

安东尼奥·罗西博士，肿瘤学/血液学卓越中心高级医学总监，IQVIA

安朱·高帕博士 医学总监，肿瘤科/血液科，医学科学与战略，IQVIA亚太区

施韦塔·普拉丹，头，临床运营，IQVIA印度

基拉格·德赛博士，咨询肿瘤科医生, HOC Vedanta, 安拉哈巴德, 印度

范蒂塔·诺罗纳博士，印度孟买塔塔纪念中心肿瘤科教授和肿瘤内科医生

帕德米·哈里什，企业通信专员,研发解决方案,亚太地区,IQVIA,印度

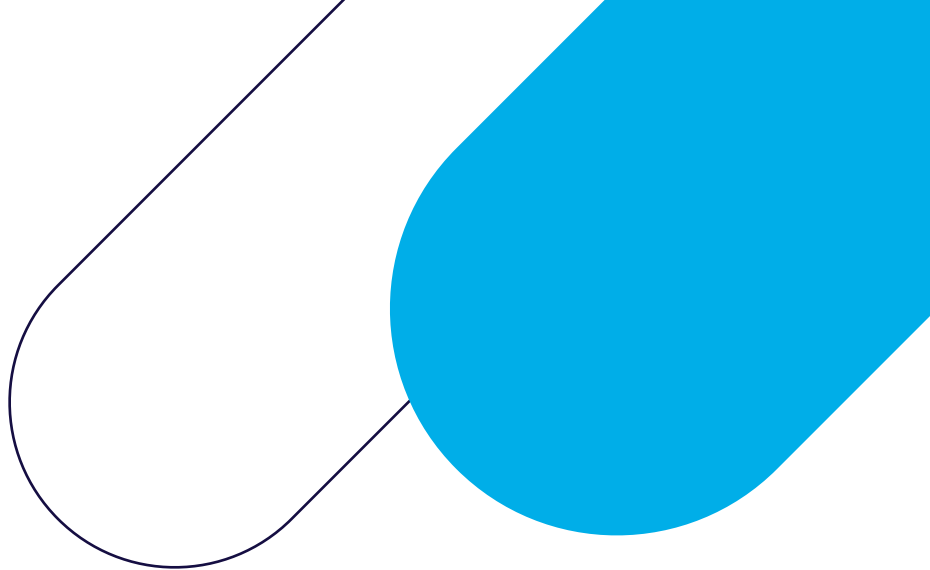
关于 IQVIA 印度

伊奇伟亚印度是伊奇伟亚（纽约证券交易所代码：IQV）的一部分，伊奇伟亚是全球领先的先进分析、技术解决方案以及向生命科学产业提供临床研究服务的公司。凭借在印度及更广泛的亚太地区的强大根基，伊奇伟亚将数据科学与人类智慧相结合，推动医疗保健事业发展。我们的创新解决方案帮助客户加速临床开发、改善患者结果，并应对复杂的监管环境。

了解更多，请访问 <https://www.iqvia.com/locations/asia-pacific/india>

参考文献

1. 聚焦印度：肺癌试验准备网络研讨会
2. NCCN小细胞肺癌 (SCLC) 指南
3. IQVIA印度



联系我们
iqvia.com